

92★★★
☑☑☑

12 歳以上では C-ACT、4~11 歳は ACT を使用する。

93★★★
☑☑☑

ACT スコアは 100 点満点である。

94★★★
☑☑☑

ACT は低い点数の方がコントロールが良好と判断される。

95★★★
☑☑☑

ACT スコアの MCID (minimal clinically important difference) は 5 点であり、治療介入により 5 点以上増加した場合には臨床的に有効と判断する。

96★★★
☑☑☑

ACT は %FEV1 や FeNO と相関する。

97★★★
☑☑☑

環境因子への曝露は喘息が増悪する誘因となる。

98★★★
☑☑☑

喘息の治療目標は喘息症状をなくすことである。

99★★★
☑☑☑

喘息の治療は低用量吸入ステロイド (ICS) から開始する。

100★★★
☑☑☑

経過観察を行わず治療薬の減量を行うべきではない。

101★★★
☑☑☑

喘息重症者には経口ステロイド治療が望ましい。

102★★★
☑☑☑

重症喘息者では、末梢血好酸球数や FeNO を確認する。

103★★★
☑☑☑

ACT が少なくとも 20 点以上を維持している状態は、喘息が良好にコントロールされている指標となる。

104★★★
☑☑☑

pMDI 製剤 (ミストタイプ) は噴射と吸入のタイミング (同調) が理解できる症例に適している。

105★★★
☑☑☑

DPI 製剤 (ドライパウダー) は同調を必要としないが、吸気流速が必要である。

106★★★
☑☑☑

DPI 製剤はアルコール臭がするためアルコール過敏症には使用できない。

107★★★
☑☑☑

吸入製剤では、吸入後に口からデバイスを外して約 5 秒間息止めをすることを勧める。